# TDAH en el adulto: el diagnóstico que se esconde detrás del "burnout", la ansiedad y la depresión resistente

Buitelaar JK, Newcorn JH. Adult Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (Clinical Practice). *N Engl J Med*. 2026;395:1519-28. Publicado el 15 de octubre de 2026. doi:10.1056/NEJMcp2516040

Versión 1.0 · Revisado el 25 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
**Refuerza buscarlo en el adulto**
Sin datos nuevos; ordena el diagnóstico y el tratamiento.

¿QUÉ TAN SÓLIDA ES LA EVIDENCIA?
**Revisión clínica experta**
Apoyada en metaanálisis en red y guías alineadas; con opinión de los autores.

LO MÁS ÚTIL PARA LA CONSULTA
**Pregunta por la infancia**
Y por el trabajo, la pareja y el manejo del tiempo, sobre todo en mujeres.

**En 30 segundos.** El TDAH persiste en la edad adulta en al menos un tercio de los casos y afecta a ~2.5 % de los adultos jóvenes. En el adulto la hiperactividad se vuelve inquietud interna, y la inatención, mala planeación y manejo del tiempo. Casi siempre coexiste con ansiedad, depresión, trastornos del sueño o consumo de sustancias, y con obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades inflamatorias. El diagnóstico es clínico (DSM-5-TR, ≥5 de 9 síntomas a partir de los 17 años, con síntomas antes de los 12). El tratamiento combina psicoeducación, fármacos (estimulantes de acción prolongada como primera opción en la mayoría de las guías) e intervenciones psicosociales.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

**Quién mide el desenlace cambia el tamaño del efecto.** En el mismo metaanálisis en red, los estimulantes tuvieron un efecto de 0.39 cuando el paciente calificó sus síntomas y de 0.61 cuando lo hizo el clínico. Además, este formato del NEJM (viñeta, evidencia, guías y recomendación de los autores) mezcla datos con opinión experta: hay que distinguir qué parte viene de estudios y qué parte del juicio de los autores.

## 1 Qué tipo de artículo es y cuánto pesa su evidencia

| | |
|---|---|
| TIPO | "Clinical Practice" del NEJM: caso clínico, estrategias y evidencia, áreas de incertidumbre, guías y recomendaciones de los autores. No es revisión sistemática. |
| BASE DE LAS CIFRAS | Metaanálisis en red de fármacos en adultos, metaanálisis de terapia cognitivo-conductual, estudios de registros escandinavos y de aseguradoras, y la cohorte MTA. |
| GUÍAS CITADAS | NICE NG87 (Reino Unido), CADDRA (Canadá) y AADPA (Australia, actualizada en enero de 2026); en EUA, guía de APSARD en preparación. Los autores las describen como "muy alineadas". |
| CONFLICTOS DE INTERÉS | Las declaraciones están en NEJM.org; no se incluyeron en el PDF revisado. |

## 2 El problema en números

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Prevalencia mundial | 5.3 % en niños · 2.5 % en adultos jóvenes |
| Persistencia en la edad adulta | Al menos un tercio de los casos; el deterioro funcional persiste en una proporción aún mayor |
| Razón hombre:mujer en adultos | Aproximadamente igual |
| Heredabilidad | ~80 % |
| Adultos sin otro trastorno psiquiátrico | Solo 10 a 40 % |
| Esperanza de vida frente a controles | 7 años menos en hombres · 9 años menos en mujeres |

**DATO DEL ARTÍCULO** El TDAH se asocia a obesidad, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, diabetes tipo 1 y 2 y enfermedades inmunes e inflamatorias, con inicio más temprano, peor evolución, retraso en buscar atención y menor apego al tratamiento. Gran parte de la asociación se explica por factores genéticos compartidos.

## 3 Cómo se ve en el adulto y cómo se diagnostica

**Presentación.** Inatención: distracción, olvidos, mala planeación, mal manejo del tiempo. Hiperactividad: inquietud interna, incapacidad para relajarse. Impulsividad: interrumpir, comentarios impulsivos, gastos o decisiones impulsivas; en casos graves, agresividad al conducir. La **desregulación emocional** no es criterio, pero está presente en la mayoría.

**Criterios DSM-5-TR en ≥17 años:**

- ≥5 de 9 síntomas de inatención **o** ≥5 de 9 de hiperactividad-impulsividad (≥6 antes de los 17).
- Varios síntomas presentes **antes de los 12 años** y en ≥2 ámbitos.
- Duración ≥6 meses, con deterioro social, académico o laboral.
- No se explican mejor por otro trastorno (depresión, consumo de sustancias).

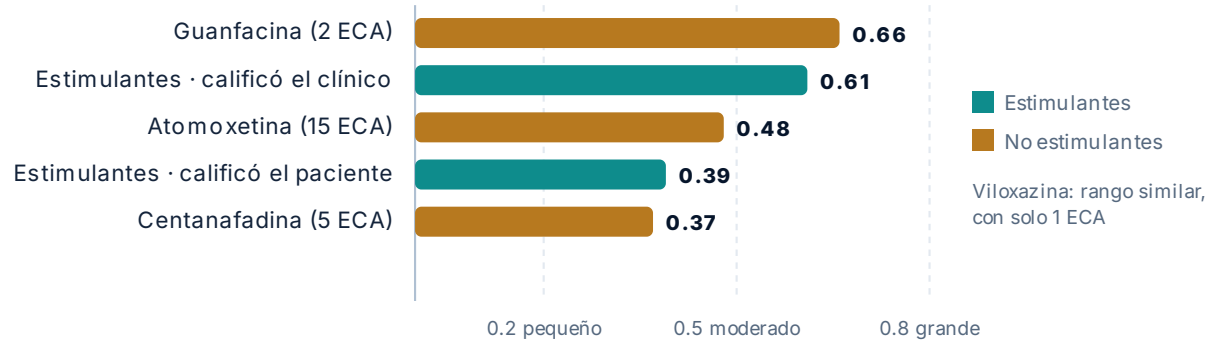
**Evaluación.** Es un diagnóstico clínico: entrevista del paciente, escalas para recoger síntomas actuales y de la infancia, e información de un tercero (pareja o padres). No hay prueba de laboratorio; las pruebas neuropsicológicas solo ayudan a caracterizar.

**TRAMPAS DIAGNÓSTICAS**

**Recuerdo de la infancia poco confiable:** los síntomas pasan inadvertidos con familia o escuela de apoyo, baja exigencia o inteligencia alta.
**"TDAH de inicio tardío":** si los síntomas aparecen solo con consumo intenso de sustancias u otro trastorno psiquiátrico, no se diagnostica.
**Depresión resistente:** buscar TDAH, porque confunde la respuesta al tratamiento.
**Mujeres:** se diagnostican más tarde, compensan o enmascaran los síntomas y consultan por ansiedad o depresión; los cambios hormonales (ciclo menstrual, embarazo, posparto, menopausia) pueden imitarlo o agravarlo.

## 4 Tratamiento: qué tan grande es cada efecto

**Tamaño del efecto sobre síntomas centrales (diferencia de medias estandarizada)**




Esquema elaborado con los datos de la tabla 2 del artículo, que proviene de metaanálisis distintos. **INTERPRETACIÓN** La guanfacina aparece arriba con solo 2 ensayos (y es de uso fuera de etiqueta en adultos en EUA); el número de estudios importa tanto como el tamaño del efecto. No es una comparación directa.

**Estimulantes (metilfenidato y anfetaminas).** Primera opción en la mayoría de las guías, sin diferencia significativa entre clases. Preferir **acción prolongada** (8 a 12 h; algo más con anfetaminas); puede agregarse liberación inmediata para cubrir el resto del día. Titular con visitas frecuentes y escalas. Meta: **reducción de 40 a 50 %** de los síntomas.

**No estimulantes.** Atomoxetina (inhibidor de recaptura de noradrenalina), viloxazina de liberación prolongada, guanfacina y clonidina de liberación prolongada (fuera de etiqueta en adultos en EUA) y bupropión (fuera de etiqueta). Ventajas: no son controlados, duran más y no tienen potencial de abuso. Evaluar respuesta inicial a las 2–4 semanas.

**Terapia cognitivo-conductual dirigida a TDAH** (reestructuración cognitiva, metacognición, entrenamiento organizacional, terapia dialéctico-conductual). Efectos: funcionamiento laboral 1.00, académico 0.48, global 0.47, social 0.36 y calidad de vida 0.28; efecto limitado sobre síntomas centrales. Útil para la desorganización, que los fármacos tratan peor.

**Sin eficacia en síntomas centrales:** dispositivos, juegos terapéuticos y neuromodulación; el neurofeedback no ha sido alentador. Hay pocos estudios de dietas y suplementos.

## 5 Seguridad: lo que hay que vigilar

| TEMA | LO QUE DICE EL ARTÍCULO |
|---|---|
| Efectos de estimulantes | Menos apetito y peso, insomnio inicial, aumento de frecuencia cardiaca y presión. Irritabilidad en el pico o al terminar el efecto; aplanamiento afectivo. |
| Riesgo cardiovascular | El uso prolongado aumenta algo el riesgo cardiovascular, sobre todo **hipertensión**. Antes de iniciar: antecedentes personales y familiares, presión, pulso y peso; ECG solo si hay hallazgos relevantes. |
| Abuso de sustancias | El metaanálisis más reciente y la cohorte MTA no muestran más riesgo ni protección; registros escandinavos y de aseguradoras muestran **menos** abuso con tratamiento. Se puede tratar con estimulantes a quien tiene TDAH y consumo. Vigilar desvío y mal uso, sobre todo con liberación inmediata. |
| Psicosis | Riesgo muy bajo, en personas vulnerables o con dosis altas. |
| No estimulantes | Sedación al inicio o al subir la dosis; náusea con inhibidores de recaptura de noradrenalina; estos suben frecuencia cardiaca y presión, los agonistas α2 las bajan. |
| Embarazo y lactancia | Riesgo bajo de teratogenia y de trastornos del neurodesarrollo; pequeño aumento de bajo peso y preeclampsia. Lactancia generalmente segura, sobre todo con metilfenidato. Guías: psicosocial en TDAH leve y fármaco en moderado a grave. |

**Pregunta de repaso: los estimulantes tuvieron un tamaño de efecto de 0.61 calificado por el clínico y de 0.39 calificado por el paciente. ¿Cuál es "el verdadero"?**

**Respuesta.** Los dos miden cosas distintas. El clínico puede percibir más cambio (y, si sabe qué recibe el paciente, sesgarse); el paciente reporta su experiencia, que es lo que define el beneficio para él. Al leer un ensayo, revisa quién calificó el desenlace y si estaba cegado; en la consulta, mide ambos: escala del clínico y metas personales del paciente.

### ¿Qué aprendí de medicina?

- ~2.5 % de los adultos jóvenes tiene TDAH; casi siempre con otro trastorno.
- Busca síntomas antes de los 12 años y en ≥2 ámbitos; pide información a un tercero.
- Estimulante de acción prolongada como primera opción; meta de 40–50 % menos síntomas.
- Presión, pulso y peso antes y durante el tratamiento.

### ¿Qué aprendí de investigación?

- El tamaño del efecto depende de **quién** mide el desenlace.
- Un efecto grande con 2 ensayos pesa menos que uno moderado con 15.
- En "Clinical Practice", separa la evidencia de la opinión de los autores.
- Asociaciones de registros (menos abuso con tratamiento) no prueban causalidad.

## 6 Referencias


1. Buitelaar JK, Newcorn JH. Adult Attention Deficit–Hyperactivity Disorder. *N Engl J Med*. 2026;395:1519-28. doi:10.1056/NEJMcp2516040
2. National Institute for Health and Care Excellence. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87).


Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico. Revisa ficha técnica y disponibilidad local de cada fármaco.